

07/08
16h

INDICADO POR: Amigo / PSG
() ACOMPANHAMENTO () CONSULTA
NS

ELISA YOSHIDA

IDADE: 63 PESO: 63 ALTURA: 1,45 PROFISSÃO: Comerciante / 9 - 18:30 29/06/2021
SINTOMAS: Deficit Memória / 9 - 16:00 sábado

QUEIXAS: Insônia, sonolência excessiva diurna; Para inglês

MEDICAMENTOS: HAS (Omeca), Rosuvastatina

MÉDICO: Dr. Márcio Jorge. Fica

MARCAPASSO: () S () N / COMPANHEIRO USA MARCAPASSO: () S () N

EXERCÍCIO FÍSICO: musculação

HORÁRIO DAS REFEIÇÕES: CAFÉ: ALMOÇO: LANCHE: JANTAR:

HORA QUE DORME: 20:00 - 1h. HORA QUE ACORDA: 6:15

COCHILLO () S () N DORME ACOMPANHADO: () S () N () EVENTUALMENTE

TEM FILHOS: () S () N / DORMEM NO QUARTO: () S () N PET NO QUARTO: () S () N

BEBIDA ALCOÓLICA: () S () X NA SEMANA () N no chás

FUMO: () S () MAÇO/DIA () NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:

TIPO DE RESPIRAÇÃO: BANHEIRO/NOITE:

CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL: ↑ CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:

OVERLAP: MALLAMPATI: IAH: 49,3 cm SPO2: 68% → PSG em 2021

PATOLOGIAS ASSOCIADAS: Sinusite Duas apnéias: 59 seg.

DOR região sacra. Faz inglês (20-21hs)

CIRURGIAS: (N) NASAL (N) AMIGDALECTOMIA

HIPERVENTILAÇÃO DA OBESIDADE:

COMORBIDADE: () RESPIRATÓRIA () ENDÓCRINA (S) CARDÍACA Dr. Carlos Alberto

() ORTOPÉDICA () NEUROLÓGICA () OUTROS: Ugoelmann

POLISSONOGRAMA COM CPAP: () S () N SPO2 C/ CPAP: PRESSÃO NO EXAME:

15/07/2025 - Avaliação Auto 4^a ao cmH₂O Dr. Flávio Rangel

máscara (M). Dr. Pedro Maciel

24/07/25 P = 7.7 cmH₂O

IAH = 2.8

m. de uso: 4h24'

fuga = 1.7 epu.

Oriento p/ colocar o cabelo em cima da fixador.

fuga.

Nome: ELISA YOSHIDA

Data de Nascimento: 14-11-1962

MC: 32,82

Sexo: Feminino

Data do exame: 30-01-2021

Peso: 69 kg

Altura: 1,45 m

Médico: DR. MARIO SILVA JORGE

Medicamentos:

Histórico:

Laudo de Polissonografia

Exame realizado na noite de 30-01-2021, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 438,5. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 16,0 e 253,5 minutos. O tempo total de sono foi de 264,0, eficiência de 60,2% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 3,4%; estágio N2: 71,0%; estágio N3: 8,0%; sono REM: 17,6%. O índice de despertares foi de 24,1/hora (normal < 10/h).

O índice de apneia/hipopneia total foi de 49,3/hora, sendo elas 20 obstrutivas, 0 mistas e 0 centrais e 129 hipopnéias. A SpO2 média foi de 92% e mínima de 68%, permanecendo 7,3% do tempo de registro com a saturação abaixo de 90%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 46 - 88 bpm e NREM de 46 - 92 bpm.

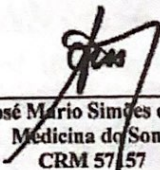
CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (10), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono reduzida;
2. porcentagem do sono REM e do estágio N3 do sono NREM diminuída e porcentagem do estágio N2 do sono NREM aumentada;
3. índice de apnéia + hipopnéia (IAH) de 49,3/hora;
4. houve dessaturação da oxihemoglobina (min. SaO2=68%);
5. latência para o sono REM aumentada;
6. aumento do número de despertares breves;
7. registro de ronco intenso durante o sono.

Exame evidenciando apneia obstrutiva do sono de grau acentuado.

IAH: 05-15 /hora leve.
IAH: 15-30 /hora moderada.
IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57157